

中山醫學大學附設醫院

主題名稱	肝硬化 Liver Cirrhosis				
編號	A31000-Q03-W-D02	制定者	N16 蔡富卿	公布日期	97 年 05 月 31 日
制定單位	護理部	核准者	吳姿蓉	修正日期	114 年 10 月 08 日
版本/總頁數	第 4.0 版/12 頁	審查者	曾翊鍵	檢閱日期	114 年 10 月 08 日

一、目的

讓護理人員了解肝硬化的定義、症狀、常見檢查、常見治療、護理問題與措施及衛教指導，有更適切之照護能力，提供最佳服務品質。

二、範圍

護理部各單位（含中興分院）。

三、說明

（一）定義

肝硬化為肝臟慢性代償性疾病，是多種肝臟疾病的終點，例如：慢性肝疾病、酒精性肝硬化、化學藥劑導致壞死性肝硬化、膽源性肝硬化、心因性肝硬化。只要有瀰慢性發炎且肝細胞有纖維化產生，造成肝臟結構上和功能上的異常即稱之。肝病到肝硬化常因為慢性長期性發炎反應，導致肝出現血管新生、實質性病變，血管結構紊亂導致肝內阻力增加出現門脈高壓、全身血管舒張，導致病患出現腹水、肝腎症候群、腸胃道靜脈曲張，最後成為肝衰竭。

（二）症狀

1. 早期無症狀可能只有消化不良、噁心、嘔吐的症狀。
2. 與腸胃道有關的症狀：厭食、消化不良、腹脹、肝臭味(hepatic odor)、食道靜脈曲張(esophageal varices)、腹水、腸胃道出血、肝脾腫大、右上腹部疼痛。
3. 與肝功能衰竭有關的症狀：食慾不振、體重減輕、身體虛弱、腹部不適、黃疸、皮膚乾燥、月經失調。

主題名稱	肝硬化	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-D02	版本	第 4.0 版	頁碼/總頁數	2/12

4. 末期：主要和門脈高壓延伸的疾病有關，腹水、食道靜脈曲張、可能隨時會有吐血情形。當合併有腹水時，有較高風險引發危及生命的合併症，例如：頑固性腹水、自發性腹膜炎或肝腎症候群。
5. 出現蜘蛛狀血管性瘤於前胸、面部及手臂、手掌發紅、肝腫大、周邊水腫、杵狀指。

（三）常見檢查

1. 腹部超音波(Abdominal echo)：用以了解腹水蓄存的位置及是否有肝癌或埋邁系統阻塞情形。
2. 腹部放液術(Abdominal Paracentesis)：屬於診斷性檢查，是治療腹水前的基本檢查項目，鑑別腹水的形式與造成的原因，協助診斷疾病及治療。
3. 胃鏡(Panendoscopy)。
4. 肝臟穿刺術(Liver biopsy)。
5. 電腦斷層掃描(Computerized Tomography)。
6. 血液生化檢查：了解肝功能及體液電解質狀況，協助治療計畫。

（四）常見治療

1. 藥物治療：

- (1) Albumin。
- (2) Lasix。
- (3) Haldol。
- (4) Neomycin。
- (5) kentamin。
- (6) Gascon。
- (7) Vit K1。
- (8) Somatosan。
- (9) Sandostatin。
- (10) Lactulose。

主題名稱	肝硬化	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-D02	版本	第 4.0 版	頁碼/總頁數	3/12

(11)Biofrmin。

(12)C-Meta。

(13)DMP。

(14)Ditopax。

(15)Primperan。

(16)VitB1。

(17)Zeffix。

2. 輸血治療：

當病人發生食道靜脈曲張或腸胃道出血情形，輸血以補充流失量。

3. 飲食治療：

(1)採『適當蛋白質』、『高熱量』、『低脂肪』之飲食。

(2)當病人出現肝昏迷或意識混亂者，須限制蛋白質的攝取。

(3)禁止酒精攝取。

(4)補充綜合維他命。

(5)腹水的病人，應食用低鈉飲食，並限制水份一天不超過 1500-2000cc。若使用利尿劑則需每天量測體重（若有腹水合併足部水腫，治療目標為每天體重下降 2 公斤，若只有腹水則為 0.5 公斤）。

(6)有食道靜脈曲張應避免粗糙堅硬食物，防止因食物摩擦導致曲張的靜脈破裂造成出血，建議食用冷、軟食並注意細嚼慢嚥。

4. 心理治療：

護理人員當發現肝硬化病人反覆入院的頻率隨著病程進展而增加時，護理人員可藉由疾病嚴重度分級評估，及早發現肝硬化病人生理、心理層面健康問題，更應主動照會醫護團隊，瞭解病人再入院原因，適時召開跨團隊會議或提供轉介，進一步處理病人合併症加劇狀況。當護理人員評估病人肝硬化末期時，引導病人及家屬瞭解緩和醫療護的資訊，再深入了解病人及家屬對生命末期的期望，以幫助病人面對死亡恐懼，以達到生理、心理的治療。

主題名稱	肝硬化	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-D02	版本	第 4.0 版	頁碼/總頁數	4/12

(五) 護理問題

1. 缺乏營養／因疾病。
2. 思想過程異常／慢或肝病。
3. 皮膚狀態不完整性／搔癢。
4. 體液容積太多／調節機轉失調（肝）。
5. 體液容積太多／出血、血小板、血紅素減少。

(六) 護理措施

1. 缺乏營養／因疾病

- (1) 依醫囑測量體重。
- (2) 依醫囑監測血液白蛋白檢驗值變化。
- (3) 配合病人食物喜好選擇高蛋白質、高熱量食物。
- (4) 建議少量多餐以增加進食量。
- (5) 進食前避免執行疼痛措施。
- (6) 採坐姿或半坐姿進食並給予充分時間進食、勿催促，必要時協助進食。
- (7) 教導進食前給予口腔護理以增加味覺。
- (8) 建議清淡飲食，避免辛辣、刺激性食物。
- (9) 衛教營養狀況少於身體需要的症狀，徵象及避免的重要性。

2. 思想過程異常／慢性肝病

- (1) 測量生命徵象，觀察其意識型態。
- (2) 監測其血液檢查值：維持正常血中氨值，注意體液電解質的平衡。
- (3) 給予床欄使用，教導家屬在旁陪伴，注意安全。
- (4) 藉由語言，冷靜及關懷的態度，以提供病人安全的保證。
- (5) 減少環境的刺激。
- (6) 對病人表同感及無條件的正向尊重。
- (7) 必要時依醫囑來約束病人。
- (8) 提供病人定向感。

主題名稱	肝硬化	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-D02	版本	第 4.0 版	頁碼/總頁數	5/12

3. 皮膚狀態不完整性／搔癢

- (1)評估病人癢的原因。
- (2)衛教病人儘量不要在太陽下曝曬。
- (3)衛教病人及家屬個人衛生的重要性，並協助維護病人身體的清潔。
- (4)衛教病人當皮膚癢時勿搔抓，以免破皮，可以輕拍皮膚來改善。
- (5)病人意識混亂時，提供手套或約束以預防搔癢。
- (6)衛教勿使用熱水洗澡，且使用中性的香皂。
- (7)建議使用潤滑劑保護皮膚和維持適當的水份。
- (8)依醫囑給予抗組織胺和止癢藥物。
- (9)協助病人剪短指甲。
- (10)維持衣物床褥的通風及乾淨。
- (11)建議穿較易吸汗的棉質衣服。

4. 體液容積太多／調節機轉失調（肝）

- (1)每天量體重。
- (2)監測攝入量和排出量，監測檢驗值。
- (3)依病情限制水份、鹽份攝取量，並衛教其重要性。
- (4)依醫囑給予利尿劑。
- (5)評估周邊水腫。
- (6)評估呼吸音。
- (7)評估生命徵象。
- (8)監測動脈血氣體分析和胸部 X 光。
- (9)依醫囑給予氧氣。
- (10)改變姿勢，以減輕呼吸困難。
- (11)抬高水腫部位。
- (12)給予被動與主動的關節運動。
- (13)水腫部位，提供適當的皮膚照顧。

主題名稱	肝硬化	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-D02	版本	第 4.0 版	頁碼/總頁數	6/12

5. 容易傷害／出血、血小板、血紅素減少

- (1) 避免使用 Aspirin（阿斯匹靈）製劑。
- (2) 避免挖鼻孔和擤鼻涕。
- (3) 避免任何引起創傷的情況，例如劇烈活動、與粗糙面的摩擦。
- (4) 使用軟毛牙刷，避免傷害牙齦。
- (5) 執行侵入性治療，例如抽血時，應延長壓迫止血時間，至完全止血為止。
- (6) 監測生命徵象、意識狀態之變化及出血表徵。
- (7) 評估且去除病人的危險因子：精神狀況、活動時之耐力。
- (8) 評估去除環境的危險因子，如：當病人臥床時，隨時圍上床欄、病床輪子固定、漸進式活動、穿不會滑的拖鞋，並鼓勵至少一位家屬隨時陪伴病人、告知家屬及病人如何使用呼叫鈴。
- (9) 指導有關出血的預防和症狀評估。
- (10) 告知病人及家屬對於早期出血的處理方法如：平躺休息，不要亂動、壓迫出血處、儘快通知醫護人員處理。

（七）衛教指導

1. 上腸胃道出血的預防方法

- (1) 營養要均衡，多吃高營養、高蛋白的食物。
- (2) 採取少量多餐的飲食習慣。
- (3) 避免暴飲暴食。
- (4) 吃飯要定時，上班、上學的人最好早起，從容的吃早餐。
- (5) 少吃刺激胃酸分泌增加的食品，如太辣、太鹹、太酸的食物，可樂、汽水、茶等。
- (6) 進食時需充分咀嚼，緩慢進食，飯後應有短時間的休息。
- (7) 避免抽煙、喝酒、喝咖啡。
- (8) 每天應有一定的休息時間、睡眠、避免熬夜。
- (9) 每天應有適當的休閒娛樂，以放鬆緊張心情。

主題名稱	肝硬化	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-D02	版本	第 4.0 版	頁碼/總頁數	7/12

(10)避免高壓力的工作或工作過度勞累。

(11)不要亂服用止痛劑、類固醇及水楊酸類的藥物。

(12)經常做抒解壓力的運動：

A.找一個舒適不受干擾的環境。

B.用力收縮肌肉並維持肌肉收縮狀態 5-7 秒。

C.迅速而完全放鬆肌肉、精神也應同時放鬆。

D.每一部份肌肉應同時收縮、一起放鬆。

E.依下列順序收縮、鬆弛肌肉。

左（右）手前臂→左（右）二頭肌→左（右）手和前臂→左（右）二頭肌→前額→眼睛→嘴巴和下額→喉和頸部→背部→胸部→胃部→臀部→大腿→小腿。

(13)瞭解出血復發之徵象：吐血、解黑便、昏厥、口渴、恐懼坐立不安、呼吸困難等、若有復發的情形、應儘早就醫、定期接受檢查可防止再復發的機會。

2. 飲食衛教

(1)適當蛋白質及熱量：

重要性：可避免蛋白質攝取過多無法代謝導致肝性腦病變。

A. 儘量攝取動物性蛋白質，例如：雞蛋、牛奶、瘦肉。但乳酪奶酥不宜多吃。

B. 每日所需的熱量可由下列含熱量高，且蛋白質極低之食物供給如：糖、蜂蜜、粉條、水果，並減少由高脂肪食物獲得熱量例如：肥肉、油炸食物、花生、腰果、蛋糕應減少脂肪攝取。

C. 急性期之肝性腦病變患者須禁止攝取蛋白質。

(2)低鈉飲食：

重要性：避免水腫腹水產生。

A. 減少使用含鈉調味品例如：鹽、烏醋、豆瓣醬、味精、醬油、蕃茄醬、

主題名稱	肝硬化	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-D02	版本	第 4.0 版	頁碼/總頁數	8/12

沙茶醬、味噌。

- B. 避免加鹽製成的加工品及醃製食品，例如鹹麵包菜、冷凍蔬菜、鹹餅乾、洋芋片、鹹蛋、皮蛋、泡菜、醃肉、臘腸、豆腐乳、醬菜、板鴨、榨菜、冷凍蔬菜。

- C. 烹調美味的低鈉飲食：

酸味：使用白醋、檸檬、蘋果、鳳梨、蕃茄等，可增加酸味。

糖醋：可利用糖醋來調味，增加食物酸甜的風味。

甘美：利用香菇、海帶、香菜來增加食物美味。

中藥材利用：甘草、當歸、黑棗、紅棗、枸杞。

強烈風味蔬菜及調味料利用：使用蒜、蔥、薑、八角胡椒、香草片等味道較強的物品添增食物風味。

利用烤、蒸、燻、燉來增添味道。

低鹽調味品利用：可運用薄鹽醬油或低鈉鹽來代替調味。

3. 併發症及如何預防：

(1) 門脈高壓及食道靜脈曲張預防：

- A. 避免用力動作，會增加腹壓及胸壓。
- B. 避免進食粗纖維食物，會造成食道損傷。
- C. 避免進食辛辣食物，會造成食道黏膜損傷。
- D. 有出血現象前應擬定緊急救護計劃。

(2) 腹水及水腫預防：

- A. 依據醫師所開的藥物使用，例如：利尿劑、白蛋白。
- B. 飲食採取低鈉及限制液體的攝取。
- C. 除非是有肝性腦病變否則可攝取適量蛋白質。
- D. 每天量腹圍、磅體重，監測體液是否滯留。
- E. 避免服用阿斯匹靈，因此藥會刺激前列腺素分泌。
- F. 觀察皮膚彈性、水份之變化，是否有水腫現象產生。

主題名稱	肝硬化	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-D02	版本	第 4.0 版	頁碼/總頁數	9/12

G. 評估呼吸型態

(3) 肝性腦病變預防：

A. 減少食物中蛋白質的量（20-40g／天）。

B. 預防腸胃道出血，避免辛辣刺激的食物。

C. 按時定量服用藥物，例如：Neomycin、lactulose 以降低腸內道細菌產生
氨。

4. 其他注意事項：

(1) 避免便秘及用力解便。

(2) 有腹水產生的病人，可採半臥或高坐臥，以利呼吸。

(3) 有出現下肢水腫情形，鼓勵活動和將下肢抬高，以促進靜脈回流。

(4) 有肝昏迷症狀的病人：

A. 臥床休息時予床欄拉上，並在床欄加上護墊，防碰撞引起損傷。

B. 協助口腔護理以減輕肝臭的異味。

C. 安排安靜的環境避免刺激病人。

(八) 實施及修訂

本辦法經護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施，修正時亦同。

四、使用表單

(略)

五、流程圖

(略)

六、參考資料

- (一) 李薇莉、周繡玲(2020). 消化系統疾病護理·於劉雪娥總校閱，內外科護理學下冊
(八版，459-468頁)·台北市：華杏。

主題名稱	肝硬化	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-D02	版本	第 4.0 版	頁碼/總頁數	10/12

- (二) 郭鈞育、李沛璋、侯明志 (2021)。肝硬化及慢性肝病患者之營養評估與治療策略。《臨床醫學月刊》，87(5)，310-320。https://doi-org.sw.lib.csmu.edu.tw:8443/10.6666/ClinMed.202105_87(5).0053

七、附件

(略)

主題名稱	肝硬化	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-D02	版本	第 4.0 版	頁碼/總頁數	11/12

八、文件修正紀錄

修正日期	版本	修正說明	備註
97.05.31	1.0	新制定	97 年 05 月 31 日 護理部照護標準委員會通過
99.08.31	2.0	配合本院 SOP 格式改版	
100.08.31	2.1	修改錯別字	100 年 08 月 31 日護理部照護標準委員會通過
101.08.31	2.2	醫護部改護理部	101 年 08 月 31 日護理部照護標準委員會通過
102.02.08	3.0	配合標準化文件管理辦法修正公布日期及進行年度臨時檢閱	
103.06.30	3.0	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
103.08.31	3.1	更新部份說明內容	103 年 08 月 31 日護理部照護標準委員會通過
104.08.31	3.2	第六項參考資料文獻部份內容更新	104 年 08 月 31 日護理部照護標準委員會通過
105.08.31	3.3	1. 新增參考文獻出處於內文中。 2. 更新第六項參考資料。	105 年 08 月 31 日護理部照護標準委員會通過
106.08.31	3.4	1. 新增參考文獻出處於內文中。 2. 更新第六項參考資料。	106 年 08 月 31 日護理部照護標準委員會通過
107.06.29	3.4	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
107.09.12	3.5	第二項新增（含中興分院）。	107 年 09 月 12 日護理長會議通過
108.09.23	3.6	1. 第三項參考文獻修訂。 2. 第三項第二目之 4、6 新增說明內容。 3. 第三項第八日本辦法經委員會通過後公布實施，改為護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施。 4. 第六項參考資料修訂。	108 年 09 月 11 日護理長會議通過;108 年 09 月 23 日督導會議通過公布。

主題名稱	肝硬化	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-D02	版本	第 4.0 版	頁碼/總頁數	12/12

修正日期	版本	修正說明	備註
109.08.18	3.7	第六項參考資料修訂。	109 年 08 月 06 日照護標準組會議通過；109 年 08 月 12 日護理長會議通過；109 年 08 月 18 日督導會議通過公布。
110.08.05	3.7	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
111.09.06	3.8	1. 第三項第一、二、三、四目說明內容文字修訂。 2. 更新第三項第五、六目護理問題。 3. 修訂第六項參考文獻資料。 4. 內文參考文獻引用刪除。	111 年 08 月 04 日照護標準組會議通過；111 年 08 月 10 日護理長會議通過；111 年 09 月 06 日督導會議通過公布。
112.08.03	3.8	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
113.09.03	3.9	刪除第六項參考資料年限較久參考文獻。	113 年 08 月 08 日照護標準組會議通過；113 年 08 月 14 日護理長會議通過；113 年 09 月 03 日督導會議通過公布。
114.10.08	4.0	修訂第六項參考文獻資料。	114 年 08 月 07 日照護標準組會議通過；114 年 09 月 10 日護理長會議通過；114 年 10 月 08 日督導會議通過公布。